

Abstract strutturato

Psicologo di Base in Puglia — Studio Integrale HTA

Lo Psicologo di Base in Puglia — Abstract strutturato

Studio Integrale di Health Technology Assessment · L.R. 19 luglio 2023, n. 11 · Dott. Luigi De Michele · Puglia, giugno 2026

Abstract strutturato secondo il formato richiesto dalla checklist CHEERS 2022 (item 2), redatto a partire dal contenuto del Livello 3 — Executive Summary (`_livelli-piramide/livello-3-executive-summary.md`), di cui costituisce una sintesi nel formato standard contesto/obiettivo/metodi/risultati/conclusioni. Nessun dato nuovo rispetto al Tomo I e ai Livelli 1-4 della piramide.

Contesto e obiettivo

In Puglia circa 780.000–1.160.000 persone convivono ogni anno con un disagio psichico clinicamente significativo che le cure primarie attuali non intercettano in modo strutturato. La Legge Regionale 11/2023 ha istituito il Servizio di Psicologia di Base, prima in Italia; lo studio ne valuta il valore economico e sanitario atteso alla messa a regime, per orientare intensità e tempi dell'attuazione.

Metodi

Valutazione economica integrata secondo un telaio che combina il modello HTA Core Model (nove domini EUnetHTA), il Five Case Model, gli standard di rendicontazione CHEERS 2022/CHEERS-AI, e i criteri di giudizio OCSE-DAC. Prospettiva duplice: Servizio Sanitario Regionale (conto fiscale diretto) e società nel suo complesso (conto sociale indiretto e conto sanitario). Tre scenari di copertura confrontati — 620, 775 e 900 Psicologi di Base — a fronte di un fabbisogno regionale a regime stimato in 800-880 professionisti. Orizzonte statico a regime, con proiezione decennale (modello di Markov, Parte XI) e analisi di sensibilità probabilistica. Ancoraggio metodologico principale: revisione OCSE 2026, dichiarata esplicitamente prevalente sull'ancoraggio precedente (Chisholm et al., 2016, *The Lancet Psychiatry*) ovunque i due divergano.

Risultati

Nello scenario di copertura intermedio (775 professionisti), a un costo di 40,5 milioni di euro l'anno corrispondono 47,0 milioni di risparmi sanitari diretti e 27,0 milioni di benefici indiretti — un ROI lordo di 1:6,6 — con un costo per anno di vita guadagnato in buona salute di circa 9.800 euro, nettamente sotto la soglia italiana di costo-efficacia di 40.000 euro/QALY.

Il conto fiscale diretto è in attivo; il conto sanitario è il termine più solido del verdetto, fondato su evidenza clinica graduata da moderata ad alta; il conto sociale è ampiamente favorevole. I tre scenari di copertura si distinguono per intensità, non per la direzione del giudizio, favorevole in tutti e tre i casi.

Conclusioni

Il verdetto è tripartito e nettamente favorevole su tutte e tre le dimensioni — fiscale, sanitaria, sociale — mai sommate in una cifra unica. Si raccomanda l'attuazione a regime della L.R. 11/2023 secondo lo scenario di copertura intermedio (775 professionisti), con dispiegamento scaglionato sulle sei Aziende Sanitarie Locali. Limiti principali dichiarati: i risparmi sanitari diretti non hanno raggiunto significatività statistica nel trial internazionale di riferimento; il calcolo dettagliato di costi e benefici delle Parti VII-X del Tomo I resta espresso nell'ancoraggio Chisholm 2016, non ancora riconciliato punto per punto con l'ancoraggio OCSE 2026 qui riportato (si veda [_meta/status-tracker.md](#)); nessuna consultazione strutturata di pazienti/cittadini è stata condotta nella progettazione dello studio. Nessuno di questi limiti altera la direzione del giudizio.

Per il quadro metodologico completo si veda il Livello 4 ([_livelli-piramide/livello-4-sintesi-tecnica.md](#)); per l'analisi integrale, il Tomo I ([tomo-1-puglia/opera-integrale-puglia.docx](#)).